

Tema 1: Síndromes Geriátricos I: Caídas, Inmovilidad y Trastornos de la Marcha

1. Introducción y relevancia clínica

Las caídas, la inmovilidad y los trastornos de la marcha constituyen **síndromes geriátricos centrales**, de alta prevalencia en personas mayores y con gran impacto funcional. A diferencia de patologías únicas, estos síndromes se originan en la **interacción de múltiples factores**: envejecimiento fisiológico, enfermedades crónicas, polifarmacia, alteraciones sensoriales, condiciones sociales y ambientales.

- **Las caídas** son uno de los motivos más frecuentes de consulta en urgencias en mayores. Se estima que **1 de cada 3 mayores de 65 años cae al menos una vez al año**, aumentando a **1 de cada 2** después de los 80 años. Las caídas son la principal causa de **morbimortalidad traumática**, incluyendo fracturas de cadera, traumatismo encéfalo craneano y pérdida funcional.
- La **inmovilidad** es tanto causa como consecuencia de caídas y de enfermedades agudas. Se asocia a **dependencia**, **sarcopenia**, úlceras por presión, trombosis venosa profunda, infecciones respiratorias y mortalidad.
- Los **trastornos de la marcha** son expresión clínica de enfermedades musculoesqueléticas, neurológicas o descompensación general, y son uno de los predictores más fuertes de fragilidad y dependencia futura.

En el **EUNACOM**, estos temas aparecen en casos clínicos donde se evalúa:

- identificación de factores de riesgo,
- sospecha de etiologías reversibles,
- manejo no farmacológico basado en rehabilitación,
- prevención secundaria y terciaria.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a) Cambios fisiológicos del envejecimiento relevantes

El envejecimiento normal conlleva:

- Disminución de fuerza muscular (**sarcopenia**).
- Pérdida de neuronas motoras y reducción de la velocidad de conducción nerviosa.
- Alteraciones del equilibrio por deterioro vestibular, propioceptivo y visual.
- Rigidez articular y menor elasticidad tendinosa.

- Disminución de la capacidad de adaptación postural.

Estos cambios por sí solos no deberían generar discapacidad, pero sí **reducen la reserva funcional**, haciendo al adulto mayor **vulnerable**.

b) Caídas: fisiopatología multifactorial

Las caídas se explican por la interacción de:

- **Factores intrínsecos:** edad, enfermedades neurológicas, desnutrición, hipotensión ortostática, polifarmacia, alteraciones visuales.
- **Factores extrínsecos:** barreras arquitectónicas, iluminación deficiente, superficies resbaladizas.
- **Factores situacionales:** apuro, cambios posturales bruscos, uso de calzado inadecuado.

La caída implica una **pérdida súbita del equilibrio o incapacidad para reaccionar** a un desequilibrio.

c) Inmovilidad

La inmovilidad es la **reducción marcada de la movilidad** que limita las actividades cotidianas.

Es un ciclo autoperpetuado:

inmovilidad → pérdida de masa y fuerza muscular → mayor dependencia → mayor inmovilidad.

d) Trastornos de la marcha

La marcha depende de:

- integridad músculo-esquelética,
- control neurológico,
- equilibrio,
- capacidad cardiovascular.

La disfunción en cualquiera de estas fases puede alterar el patrón de marcha.

3. Clínica

a) Caídas

Síntomas:

- Dolor, incapacidad para ponerse de pie, equimosis, heridas.
- En ancianos, la caída puede ser **la primera manifestación de infección, infarto o deshidratación**.

Preguntas clave al evaluar una caída:

1. ¿Se produjo caída verdadera o síncope?
2. ¿Hubo pródromos? (mareo, visión negra, palpitaciones).
3. ¿Fue extrínseca o intrínseca?
4. ¿Hubo incapacidad para levantarse? → riesgo de rabdomiólisis.

b) Inmovilidad

Se manifiesta como:

- Reducción del movimiento espontáneo,
- Aumento del tiempo en cama o silla,
- Dependencia creciente para actividades básicas.

c) Trastornos de la marcha

Patrones clínicos típicos:

Tipo de marcha	Características	Causas frecuentes
Marcha parkinsoniana	pasos cortos, arrastre, pobre braceo	Parkinson, parkinsonismo vascular
Marcha atáxica	inestabilidad amplia base	lesiones cerebelo, neuropatías
Marcha espástica	piernas rígidas en tijera	mielopatías
Marcha por debilidad proximal	dificultad levantarse/sentarse	miopatías, sarcopenia
Marcha cautelosa del anciano	lenta, insegura, multicausal	fragilidad

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a) Evaluación funcional

- **Índice de Barthel** para ABVD.
- **Lawton-Brody** para actividades instrumentales.
- **Timed Up and Go (TUG):**
 - <10 s normal
 - 10–20 s fragilidad
 - 20 s ↑ riesgo de caídas

b) Estudios según sospecha etiológica

- Hemograma, electrolitos, glicemia, TSH, vitamina D.
- Si sospecha de síncope → ECG ± Holter.
- Si dolor o trauma → radiografía dirigida.

c) Evaluación del entorno

- Seguridad del hogar (iluminación, alfombras, escalones).
- Soporte familiar.

5. Tratamiento (según MINSAL 2019)

a) Principios generales

- El manejo es **interdisciplinario**: médico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista.
- Objetivo: **mantener o recuperar funcionalidad**, prevenir dependencia.

b) Caídas

1. **Identificar y corregir causas reversibles**
 - Ajuste de fármacos (evitar benzodiacepinas, anticolinérgicos).
 - Corregir hipotensión ortostática (hidratación, medias compresivas).
 - Tratar déficit de vitamina D y desnutrición.
2. **Rehabilitación**
 - Ejercicio multicomponente y entrenamiento de equilibrio.
3. **Prevención ambiental**
 - Barras de apoyo, eliminar alfombras, mejorar iluminación.

c) Inmovilidad

- **Movilización precoz**, incluso en hospital.
- Kinesioterapia progresiva.
- Nutrición proteica adecuada.
- Prevención de úlceras, TEP y estreñimiento.

d) Trastornos de marcha

- Tratamiento dirigido a la causa (p. ej., L-Dopa en Parkinson).
 - Entrenamiento de marcha.
 - Dispositivos de apoyo (bastón, andador) **indicados por Kinesiología**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

- Fracturas osteoporóticas (especialmente cadera).
- Delirium.
- Infecciones respiratorias y urinarias.
- Dependencia progresiva.
- Institucionalización.

La recuperación depende de **intervención precoz**.

La falta de tratamiento perpetúa el **síndrome de fragilidad** → **dependencia** → **mortalidad**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas

- Toda caída en el adulto mayor es **evento sentinela** hasta demostrar lo contrario.
- La marcha cautelosa es **expresión clínica de fragilidad**: no requiere lesión estructural única.
- La incapacidad para levantarse tras una caída se asocia a **rabdomiólisis**: pedir CPK.

Errores frecuentes

- Atribuir caída a “vejez” sin buscar causa corregible.
 - Indicar benzodiacepinas para ansiedad o insomnio (↑ riesgo de caídas).
 - Inmovilizar “para evitar nuevas caídas” (empeora fragilidad).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Caídas, inmovilidad y trastornos de la marcha son **síndromes geriátricos complejos**, no diagnósticos aislados.
2. La causa suele ser **multifactorial**; la evaluación debe ser integral.
3. La **sarcopenia y la fragilidad** constituyen los mecanismos fisiopatológicos subyacentes más relevantes.

4. El manejo es **funcional y preventivo**, basándose en **rehabilitación y ajuste ambiental**.
 5. El uso racional de fármacos es esencial; evitar sedantes e hipnóticos.
 6. La evaluación funcional estructurada (Barthel, Lawton, TUG) ayuda a detectar riesgo temprano.
 7. La intervención precoz **previene dependencia y reduce mortalidad**.
-